《诊断学》：腹壁静脉视诊
①上腔静脉阻塞：脐以上血流转而向下
②下腔静脉阻塞：脐以下血流转而向上
③腹壁静脉曲张：脐以上向上+脐以下向下

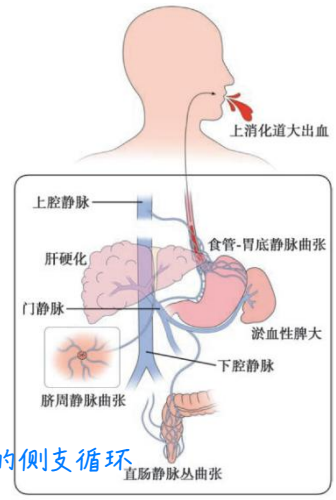
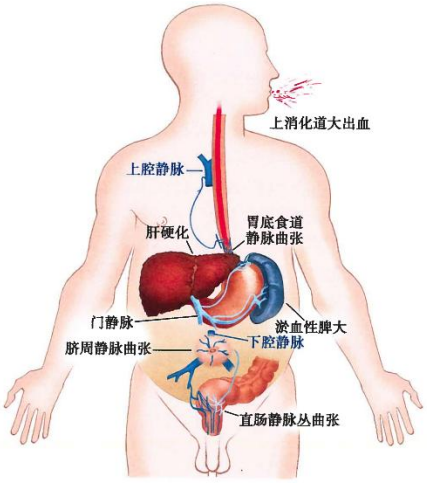


图 11-10 门静脉高压时侧支循环示意图



上述侧支循环可导致：
食管胃底静脉曲张破裂出血
肝肾综合征
肝肺综合征 杵状指
门静脉血栓形成和门静脉海绵样变 门静脉周围的侧支循环
肝性脑病 毒素(如氨气)通过侧支未经肝脏解毒直接进入体循环
自发性腹膜炎
药物半衰期延长等 药物没有经过肝脏代谢

《病理学》10 版教材 P211-212：肝功能障碍中提及肝肾综合征

5.**腹水**
肝肾综合征 ┬ 肝门静脉压力↑→腹水↑→有效循环血量↓→肾血流量↓
肝功能障碍 ┬ 对舒张血管物质灭活↓→继发缩血管物质↑→肾血管收缩
白蛋白合成障碍→锁不住水→有效循环血量↓

（1）门脉高压和肝功减退的共同结果，**失代偿期最突出**的表现

①② ③④ ⑤
（2）机制 2 个门脉高压、2 个肝功减退、1 个恶性循环
①门脉高压→腹腔内脏血管**静水压和通透性**↑→组织液回吸收减少而漏入腹腔（**决定因素**）
②门脉高压→肝**淋巴液生成增多**（肝血窦压力↑→压到淋巴里面去→淋巴液↑）、超过了淋巴循环引流能力→自肝包膜表面漏入腹腔
③肝合成白蛋白减少（**低清蛋白血症**）→血浆**胶体渗透压降低**
④肝对醛固酮和抗利尿激素灭活减弱→**继发醛固酮和抗利尿激素增多** VS 肾上腺有问题→原发的醛固酮增多(原醛)
⑤**有效循环血量减少**→肾血流减少→RAAS 激活、肾小球滤过率降低
①肾小球滤过↓→流到远曲小管致密斑的钠↓→肾素↑
②肾动脉灌注压↓→肾素↑

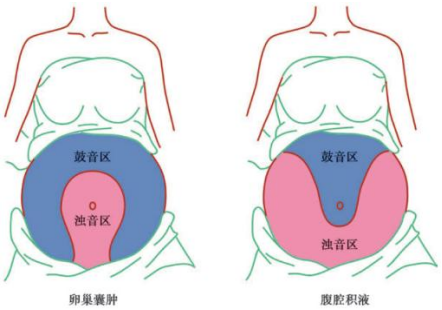


（3）表现
①腹部膨隆、ttsx **蛙腹**、腹式呼吸减弱、膈肌抬高 呼吸困难和心悸 VS振水音:液气胸、幽门梗阻
②水坑征/搔弹音（≥120ml）、**移动性浊音（≥1000ml）**、液波震颤（≥3000-4000ml）
③**漏出液：血清腹水-白蛋白梯度 SAAG≥11**（AA-11、门脉高压的高-大）
VS 结核性腹膜炎是渗出液,SAAG<11



《诊断学》：卵巢囊肿与腹腔积液叩诊鉴别

	腹水	巨大卵巢囊肿
仰卧时浊音区域	腹两侧（鼓音区在中部） 爱如腹水 它将肠管包围	腹中部（鼓音区在两侧-肠管）
浊音是否移动性	√	×
尺压试验 硬尺是否搏动	×	√ （腹主动脉搏动经囊壁传至硬尺）



①脾肿大:门脉高压最早的表现
②侧支循环:门脉高压最特征/最有价值的表现
③腹水:失代偿期最突出的表现